

3

末梢神経症状

化学療法誘発性末梢神経障害(CIPN)への対応

1 起こりやすい薬剤



タキサン系(パクリタキセル・ドセタキセル):感覚性のしびれが主体



白金製剤(オキサリプラチン等):オキサリプラチンは寒冷刺激で誘発される急性の症状が特徴的



ビンカアルカロイド系(ビンクリスチン等):運動神経にも影響し、便秘・麻痺性イレウスの原因にもなる

2 重症度の目安(CTCAE)

Grade1

軽度のしびれ、機能制限なし

Grade2

中等度、日常生活動作に制限

Grade3

高度、身の回りの動作に支障

Grade4

生命を脅かす、緊急処置を要する

3 患者さんに伝える観察ポイント



手足の先のしびれ・感覚が鈍い感じが日常生活(ボタンをかける・箸を使う等)に支障していないか



歩行時のふらつき・つまずきやすさ(転倒リスク)



(ビンカアルカロイド系の場合)便秘の悪化・排便回数の減少

4 薬剤師のチェックポイント

- ☐ Grade2以上は減量・休薬の目安になりうるため、しびれの範囲・生活への支障度を具体的に聴取し処方医にフィードバックする
- ☐ オキサリプラチン使用中は、冷たい飲食物・冷たいものに触れることを避けるよう指導する
- ☐ 症状は投与終了後も数ヶ月～数年残存することがあるため、治療終了後のフォローでも確認を続ける
- ☐ 転倒リスクが高い患者には、家庭内の環境整備(段差・滑りやすい場所)についても声かけする

CIPNは一度重症化すると回復に時間がかかる、または残存することがある。「悪化する前に伝えてもらう」ことが薬剤師の関わりで特に重要。

がん薬物療法 研修シリーズ — 副作用ガイド 3/4(末梢神経症状) — ASCO化学療法誘発性末梢神経障害ガイドライン、CTCAE v5.0に基づく